



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : همت الاحمدي عطية احمد
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة العنوان : =
رقم البطاقة : 27711151600145 رقم التليفون : 01008910068 تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-11-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع:
المقرر بما فيه (.....) التوقيع:

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129]
قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / /د. / /د. / /د. / /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: همت الاحمدي عطية احمد National ID: 27711151600145	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE)

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : همت الاحمدي عطية احمد

العنوان : =

الحي / المدينة : شبرا الخيمة

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستشارة : 18-10-2025

رقم التليفون : 01008910068

رقم البطاقة : 27711151600145

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-11-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....) (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولادكس قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: احمد نجيب الوظيفة:
الاسم: خالد عبدالعزيز الوظيفة:
الاسم: محمد كيلاني الوظيفة:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناقرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د/ أ.د/ أ.د/ د/ د/

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

همت
الاحمدى عطيه احمد

ش ٣٢ - شبرا البلد - امام كلية الزراعة
شبرا الكبيسة اول - القليوبية

١٩٧٧/١١/١٥ ٢٧٧١١١٥١٦٠٠١٤٥

HV8281740

٢٠١٩/٠١ ٢٧٧١١١٥١٦٠٠١٤٥

أنثى
هاني اسماعيل ابراهيم
متزوجة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

١١

Name: همت الاحمدي عطيه احمد			
MR. : 7427			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحيه طيبة وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was diagnosed with right-sided breast cancer on 25 November 2019, pathology revealing a T1N1, grade 2 invasive ductal carcinoma, estrogen-receptor positive, progesterone-receptor positive, HER2-negative. Initial treatment consisted of four cycles of doxorubicin-cyclophosphamide (4 AC) followed by four cycles of paclitaxel (4 taxol). After completion of chemotherapy, the patient received postoperative tamoxifen beginning in June 2020. Gonadotropin-releasing hormone agonist therapy with zoladex was initiated in November 2021 and continued until April 2025. The current plan includes continuation of an aromatase inhibitor combined with zoladex for an additional two years, along with zoledronic acid (Zometa) administered every six months, and femara. The next clinic visit is scheduled for 10 October for further zoladex administration. The patient has completed four cycles of AC and four cycles of taxol.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :			
هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

قرر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) بأن أصول مستندات الصرف ومزيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتها. تم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة أخرى للصرف.

اسم المريض	همت الاحمدي عطية احمد	الرقم القومي	٢٧٧١١١٥١٦٠٠١٤٥
قرار وزاري رقم	٢٠٢٥٣٦٠٠٣٠٢٠	بتاريخ	١٨-٠٧-٢٠٢٥ بمبلغ ٧٥٠٠
تاريخ الفاتورة	١٨-١٠-٢٠٢٥	التشخيص	سرطان بالثدي (مبادرة)
الاجراء	علاج هرموني خط ثاني + زولانديكس ودوائى واباحث	الخصم (%)	٠

مدين	بيـان	كميـة	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
٣٢.١٠	Calcium Carbonate 500mg	30	capsule	18/10/2025	
٥٩.١٠	AlfaCalcidol 0.5 mcg	30	capsule	18/10/2025	
٢٩٢.٢٠	Letrozole 2.5 mg	30	tablet	18/10/2025	
٣٨٣.٤٠	الاجمالي				

مدير الشؤون المالية



رئيس حسابات المرضى

المراجع

الموظف المختص

مکملہ فوائد

CC, B, L, V

دینا و لینا

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض: محمّد المرحوم عبد

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

رغم ما كان في صحة استعمال العلاج

المريض
محمّد المرحوم عبد

تحريراً في

التاريخ : ١٠/١٨/٢٠٢٠

الوقت:

الطبيب المعالج

يعتمد ،،



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : *Dr. Ravi Kumar*

Sex :

3- Medical number:

Female

82191293

Old Med

5/14/2019

2-ID number: 27711151600145

Patient Age: 45 Y



Family history:

Yes

Phone:

016000710065

EMI:

REASON OF MDT

marital status:

Married

NRS Score:

1/10

GROUP:

Date of MDT

2025-04-10

Co-morbidity:

No

Menopausal status:

Postmenopausal

Initial STAGE:

T1N1

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	7/8			
HER2/NEU	HER2/NEU	HER2/NEU	HER2/NEU	HER2/NEU	
T		N		M	

Sonomammography

PATIENT HISTORY

RT BCS 25/11/2019 T1N1 3/10 M0

received 4AC , 4 taxol -->PORT

start tamoxfin 6/2020 -->regression

start zoladex 11/2023

MDT OUTCOME & PLAN

AI + zoladex for 2 years

Zometa/6 month

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	<i>Dr. Ravi Kumar</i>	RADIOLOGY	<i>Dr. Ravi Kumar</i>
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Patient Name: Hemmat Al Ahmady Atteya Ahmed	Date : 12/04/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 5144/2019	Pat. ID: 11188

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had right CBS in

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UIQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaed

12/04/2025 1:09 PM



Patient Name: Hemmat Al Ahmady Atteya Ahmed	Date : 02/03/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 5144/2019	

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS in

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with dystrophic calcifications post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed:
- Right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Dr, basma mohmaed



Name: Hemat Al-Ahmady Attia

Patient ID: 109213112

Date: 17/11/2019

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -

Findings:

- Clear both lung fields with no pulmonary parenchymal masses , nodules or consolidation
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- Essentially normal CT study of the chest.

APPROVED BY

Dr.Wessam Moustafa.MD

Dr.
Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : همت الاحمدى عطيه

Age : 42 Y

Referred By Prof. Dr. : اشرف شوقي

Clinical Diagnosis : Right breast cancer

Nature of Specimen : Upper Quadrantectomy with right axillary dissection and ??deep
??skeletal muscle

Receiving Date : 25/11/2019

Patient ID : 340209

PATHOLOGY REPORT

Diagnosis :

- 1) Right breast, Quadrantectomy with right axillary dissection, MULTIFOCAL INFLTRATING DUCT CARCINOMA WITH MICROPAPILLARY PATTERN, GRADE II-III, NO INTRADUCTAL COMPONENT, AXILLARY LYMPH NODE METASTASIS. L.Ns 3/10 WITH NO CAPSULAR INFILTRATION.
- TUMOR STAGE: T1c, N1a.
- 2) Separate muscle, Biopsy, FREE SEPARATE SKELETAL MUSCLE.


30/11/2019

Dr.

Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.

Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : همت الاحمدى عطيه

Age : 42 Y

Referred By Prof. Dr. : اشرف شوقي

Clinical Diagnosis : Right breast mass

Nature of Specimen : FNAC

Receiving Date : 13/11/2019

Analysis ID : 427937

Gender : Female

Patient ID : 340209

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Microscopic :

Cytological examination of the films prepared from the aspirate revealed many red cells, groups of ductal epithelial cells showing nuclear pleomorphism with high nucleo/cytoplasmic ratio and moderate lack of cohesion.

Diagnosis :

Right breast mass, FNA, Cytology, MALIGNANT ASPIRATE, DUCT CARCINOMA.



14/11/2019



Date : 02/03/2024	Patient Name: Hemmat Al Ahmady Atteya Ahmed
Age : 47 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
	Medical ID: 5144/2019

**ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION
REVEALED:**

Liver: -

- Enlarged in size smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent.

Gall Bladder: -

- Average size, normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size (About 11 cm), displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

Are of normal size and site , normal echogenicity , no stone or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

-Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: -: anti-verted, average sized uterus. IUCD is seen in low position for TVUS

No free fluid in the Douglas pouch.

Opinion:

Bright hepatomegaly.

IUCD is seen in low position for TVUS

Marked coloin gaseous distension

Best Regards,
Dr Dina Gaber FEBR,

Not Approved



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

همت
الأحمدى عطيه احمد
فيلا ٢ / ٤ الرجن ٨
التجمع الخامس - القاهرة



١٩٧٧/١١ ٢٧٧ ١١ ١٥ ١٦ ٠٠١ ٤٥

L05493329



٢٠٢٦/٠١ ٢٧٧ ١١ ١٥ ١٦ ٠٠١ ٤٥

ربة منزل

أنثى

مسلمة

متزوجة

هالى اسماعيل ابراهيم اسماعيل

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/٠٧



